

Examen-2p-bqc preguntas cortas+t...



Alizious



Bioquímica Clínica



3º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

Una cuenta que no te pide **nada**.

Ni siquiera que apruebes. De momento.

(Estudia y no nos des ideas)

Cuenta NoCuenta

Saber más

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherida al Sistema de Garantía de Depósitos holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](#)





Test 2P bioquímica clínica

1. En un análisis de heces, el descenso del pH por debajo de 5,5 junto con un aumento en la concentración de ácido láctico:
 - a) Puede informar de intolerancia a la lactosa
 - b) Puede informar de una posible intolerancia a la sacarosa
 - c) Informa de una posible intolerancia a la isomaltosa
 - d) **Todas son correctas**
2. Con respecto a las glucogénesis musculares, es falso que:
 - a) La tipo VII o enfermedad de Tauri es una de ellas
 - b) La tipo I o enfermedad de Von Gierke no es una de ellas
 - c) **Para su diagnóstico, se utiliza el test del glucagón**
 - d) Para su diagnóstico, se utiliza el test de isquemia
3. La enfermedad de Hunter:
 - a) Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite con carácter autosómico recesivo
 - b) **Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite ligada al sexo**
 - c) Es una mucopolisacaridosis tipo I que se transmite con carácter autosómico recesivo
 - d) Es una mucopolisacardisios tipo I que se transmite ligada al sexo Hunter: dermatan sulfato, ligado al sexo
4. La esteatorrea y la linfangectasia suelen aparecer en:
 - a) Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
 - b) **Alteraciones en el metabolismo de los lípidos**
 - c) Alteraciones en el metabolismo de los Aminoácidos
 - d) Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas
5. La acantocitosis suele aparecer en:
 - a) Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
 - b) **Alteraciones en el metabolismo de los lípidos**
 - c) Alteraciones en el metabolismo de los Aminoácidos
 - d) Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas
6. El síndrome de Bassen-Kornzweig:
 - a) Es debido a una falta de tocoferol (ataxia)
 - b) Suele aparecer en alteraciones de los lípidos
 - c) Suele aparecer en caso de Abetalipoproteinemia
 - d) **Todas son correctas**
7. ¿Qué magnitud bioquímica analizarías para valorar la integridad de las células del hígado?:
 - a) Bilirrubina → Colestasis
 - b) Albúmina → Capacidad de síntesis
 - c) Fosfatasa alcalina → Colestasis
 - d) **Alanina aminotransferasa → Integridad**

8. Qué magnitud bioquímica analizarías para valorar la capacidad de síntesis de las células del hígado:

- a) Bilirrubina → Colestasis
- b) Albumina → Capacidad de síntesis**
- c) Fosfatasa alcalina → Colestasis
- d) Alanina aminotransferasa → Integridad

9. En un proteinograma, cuál de las siguientes proteínas aparece en la región Δ_2 :

- a) Albúmina
- b) Transferrina
- c) Ceruloplasmina**
- d) IgG

10. En un proteinograma, cuál de las siguientes proteínas aparece en la región β :

- a) Albúmina
- b) Transferrina**
- c) Ceruloplasmina
- d) IgG

11. En un proteinograma, cuál de las siguientes proteínas aparece en la región γ :

- a) Albúmina
- b) Transferrina
- c) Ceruloplasmina
- d) IgG**

12. Dentro de lo que se engloba como proteínas de fase aguda se incluyen:

- a) La albúmina
- b) La ceruloplasmina**
- c) Todas las proteínas de fracción β
- d) Todas las proteínas de fracción γ

13. En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:

- a) La reacción de Biuret se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- b) La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales**
- c) La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
- d) Ninguna de las opciones es correcta

14. En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:

- a) Se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas totales
- b) La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- c) La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
- d) Ninguna es correcta**

15. Con respecto a la gota, señala la incorrecta:

- a) Es un trastorno metabólico de las pirimidinas**
- b) Puede cursar con tofos
- c) Puede aparecer como gota juvenil
- d) Se caracteriza por una precipitación de cristales de urato en los tejidos

16. La xaniturina hereditaria:

- a) Se produce por acumulación de Xantina oxidasa/Xantina deshidrogenasa
- b) Cursa con hiperuricemia
- c) Es una alteración metabólica de las pirimidinas
- d) **Todas son falsas**

17. Las alteraciones en el ciclo de la urea se pueden producir por déficit de:

- a) Carbamoil fosfato sintetasa I
- b) Ornitina Transcarbamoilasa
- c) Arginino succinato sintetasa
- d) **Todas son correctas**

18. La enfermedad de la orina con olor de jarabe de arce se produce por alteración en el metabolismo de aminoácidos...

- a) **Alifáticos ramificados**
- b) Alifáticos no ramificados
- c) Básicos
- d) Azufrados

19. Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos, no se encuentra:

- a) **Fenilcetonuria**
- b) Cistinuria
- c) Iminoglicinuria
- d) Enfermedad de Hartnup

20. El albinismo:

- a) Se produce por déficit enzimático de la cistationina sintetasa
- b) Se produce por déficit enzimático de cistalionasa
- c) Se produce por déficit enzimático de triptófano
- d) **Se produce por déficit enzimático de tirosinasa**

21. En la fenilcetonuria es falso que:

- a) Es una alteración de la degradación de la fenilalanina
- b) Se produce por deficiencia en fenilalanina hidroxilasa
- c) Genera tóxicos cerebrales
- d) **Todas son ciertas**

22. Qué enfermedad afecta al transporte de los aminoácidos:

- a) Cistinuria
- b) Iminoglicinuria
- c) Enfermedad de Hartnup
- d) **Todas son ciertas**

23.) La alcaptonuria:

- a) Es una alteración del catabolismo de la prolina
- b) Está causada por la pérdida de triptófano
- c) **Produce una coloración oscura en la orina por la presencia de ácidos homogentísicos**
- d) Produce el síndrome del pañal azul por la formación de Indacán



REGÍSTRATE



24. Con respecto a la alteración de los fosfoacilglicéridos, indica la respuesta correcta:
- Los defectos en su síntesis pueden producir acúmulo de estructuras membranosas inservibles
 - Pueden cursar con descerebración
 - Se pueden producir por deficiencia en las saposinas
 - Pueden deberse a deficiencia en plasmalógenos**
25. Con respecto a la alteración de los fosfoacilglicéridos, indica la respuesta correcta:
- Los defectos en su síntesis pueden producir acúmulo de estructuras membranosas inservibles
 - Pueden cursar con descerebración
 - Se pueden producir por deficiencia en las saponinas
 - Pueden deberse a un déficit de Dipalmitoil lecitina**
26. Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los esfingolípidos, la cierta es:
- Los defectos en su síntesis pueden producir acúmulo de estructuras membranosas inservibles
 - Pueden producirse por defectos en la dipalmitoil lecitina
 - Pueden producirse por defectos en las saposinas
 - Pueden deberse en plasmanógenos
27. Pueden producir alteraciones en el metabolismo de los Triglicéridos como consecuencia de:
- Deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa
 - Deficiencia de Dipalmitoil Lecitina
 - Deficiencia en Glicerol quinasa
 - Deficiencia en HGM-CoA liasa
28. El déficit en Carnitina palmitoil transferasa (CPT) afecta a:
- La síntesis de Ácidos Grasos
 - La síntesis de los cuerpos cetónicos
 - La degradación de Ácidos Grasos**
 - La degradación de los cuerpos cetónicos
29. Las alteraciones del metabolismo de los Ácidos grasos afectan:
- La entrada de ácidos grasos en la mitocondria (carnitina)
 - β -oxidación
 - α -oxidación
 - Oxidación peroxisómica
 - Todas ciertas**
30. Qué enzimas están implicadas en el metabolismo de las lipoproteínas
- La lipoproteína lipasa o LPL
 - La lecitina-colesterol acil transferasa o LCAT
 - Triglicerido lipasa hepática o HTGL
 - Proteína transferidora de ésteres de colesterol o CEPT
 - Todas son correctas
31. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:
- La concentración de Apo B puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol
 - Las LDL-colesterol se pueden determinar por la fórmula de Friedewald

- c) Se analiza el aspecto del suero dejarlo reposar a 4°C toda la noche
- d) Todas las opciones son correctas

32. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:

- a) La concentración de Apo B puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol
- b) La concentración de Apo A puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol
- c) HDL-colesterol se pueden determinar por la fórmula de Friedewald
- d) Las LDL-colesterol se pueden determinar por ultracentrifugación y precipitación con sal de ácido fosfotúngstico

33. ¿Qué tipo de enfermedad forma parte de una dislipemia hipolipoproteínica?

- a) Abetalipoproteínica, Enfermedad de Tangier y Hipercolesterolemia familiar
- b) Abetalipoproteínica, hipobetalipoproteínica familiar y Deficiencia en la lipoproteína familiar o enfermedad de Tangier
- c) Enfermedad de Tangier, analfalipoproteínica y hipertrigliceridemia
- d) Deficiencia en LPL, abetalipoproteínica y deficiencia en la lipoproteína familiar

34. La hiperlipoproteínica tipo I de Frederickson, también se la conoce como:

- a) Hiperquilomicronemia familiar
- b) Hipercolesterolemia familiar
- c) Hipertriacilgliceridemia familiar
- d) Hiperbetaproteínica familiar

35. Según la clasificación de Frederickson:

- a) La hiperlipoproteínica tipo I se caracteriza por una hipercolesterolemia
- b) La hiperlipoproteínica tipo III se caracteriza por una hipercolesterolemia**
- c) La hiperlipoproteínica tipo VI se caracteriza por una hipercolesterolemia
- d) Todas son correctas

36. La determinación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante puesto que pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis. Sin embargo, no todas las lipoproteínas presentan riesgos aterogénicos como por ejemplo:

- a) Los quilomicrones y HDL**
- b) Los quilomicrones y LDL
- c) LDL solamente
- d) LDL y bVLD

37. ¿Cuál de las siguientes enzimas de interés clínico se eleva en plasma tras una pancreatitis?

- a) Lactato deshidrogenasa
- b) Fosfatasa alcalina
- c) Amilasa
- d) Creatinina quinasa

38. Un espécimen de orina de 24 horas puede sufrir cambios en su composición...

- a) Cuando ha sido almacenado en un recipiente de vidrio totalmente transparente
- b) Cuando el recipiente no ha sido tratado con ningún tipo de conservante para prevenir la acción bacteriana
- c) Cuando ha sido congelado y descongelado varias veces
- d) Todas las opciones anteriores son correctas**



COMIENZA 2026 CON 20 USDC

Regístrate y opera con 50 euros y llévate
20 USDC

REGÍSTRATE



Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

39. De las siguientes afirmaciones sobre las pruebas bioquímicas, ¿cuál es verdadera?
- a) Son un elemento fundamental para la diagnosis y la prognosis
 - b) Sirven para el seguimiento de una enfermedad
 - c) Se utilizan para la monitorización toxicológica y los estudios farmacológicos
 - d) **Todas las opciones anteriores son ciertas**
40. Es cierto que los intervalos de referencia (I.R)...
- a) No nos van a informar del estado de salud
 - b) Para poder establecer como intervalo fiable, son necesarios al menos 20 individuos, según lo establece la Federación Internacional de Química Clínica
 - c) Varían entre una población y otras
 - d) Son los mismos para todos los laboratorio
41. Los principales electrolitos del líquido extracelular son:
- a) Sodio, potasio y proteínas
 - b) Sodio, cloruros e hidrogenocarbonato
 - c) Potasio, cloruros e hidrogenocarbonato
 - d) Potasio, proteínas y fosfatos
42. Como consecuencia del catabolismo celular, existe una tendencia a acidificar el medio interno y los fosfatos obtenidos en este proceso van a proceder principalmente de:
- a) La degradación de los lípidos
 - b) La degradación de hidratos de carbono
 - c) La degradación de proteínas
 - d) La degradación de ácidos nucleídos
43. La Pseudonatremia puede aparecer en personas con:
- a) Hipolipidemia
 - b) Hipovolemia
 - c) Hipoproteinemia
 - d) Hiperproteinemia

Ejercicios escritos

Completa las siguientes afirmaciones:

- La glucogenosis tipo IX se debe a un déficit de glucogenosintasa y es la única que se caracteriza por déficit de glucógeno
- La glucogenosis tipo II o enfermedad de Pompe se debe a un déficit de alfa-1.4 glucosidasa por acumulación de glucógeno en los lisosomas
- La función de médula ósea es la del anidamiento, crecimiento y diferenciación de las células sanguíneas
- El valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida en 1 dL de hematíes se llama concentración hemoglobina corpuscular media (CHCM), y se calcula a partir de concentración de hemoglobina y de hematocrito.
- Para evaluar la posible intolerancia a un disacárido, se somete a una persona a la sobrecarga oral del mismo, un valor de glucemia inferior a 200 mg/dL se considera un resultado positivo.
- La enfermedad de Sanfilipo cursa entre otras cosas con alteraciones neurológicas debido a un acumulo de heparán sulfato.
- Según la clasificación de Frederickson el suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo I se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de una fuerte concentración de triglicéridos
- En la enfermedad de Hartnup, el compuesto que tiñe las heces de color azul se denomina indacan.
- La reacción de Jaffe se utiliza para cuantificar creatinina
- Los linfocitos proceden de la línea linfoide en la hematopoyesis
- En el proteinograma la presencia de una banda discreta en la fracción γ y puede ser indicativo de cantidades elevadas de ciertas proteínas o paraproteínas o componente monoclonal que puede ser signo de malignidad
- En el proteinograma la presencia de una banda débil puede ser indicativo de prealbúmina
- Una muestra de la mucosa intestinal en la que se ha detectado una deficiencia importante en la aldolasa B confirma el diagnóstico de intolerancia sacarosa? _____
- La orina con olor a jarabe de arce se produce por alteración en su metabolismo de aminoácidos alifáticos ramificados
- La glucoheteroglobina informa de la concentración en sangre de glucosa durante los 3 meses
- Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos se encuentran cistinuria, iminoglicinuria y enfermedad de Hartnup
- La enfermedad de I glucogenosis musculares se realiza el test de isquemia
- El aclaramiento de creatinina calculado en un volumen de 2160 ml de orina recogido durante 12h a una concentración de orina de 8,1 mmol/L y plasmática de 160 mmol/L fue de _____
- La enfermedad de Hunter es una mucopolisacaridosis que se transmite ligada al cromosoma X.
- Para el diagnostico de las glucogenosis musculares se realiza el test de isquemia
- Según la clasificación de Frederickson, el suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo _____ se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de un aumento en la concentración de triglicéridos
- Como consecuencia de una disfunción de los glomérulos renales, aparecerá una proteinuria _____.
- Para valorar la regulación de los líquidos corporales se realiza la _____
- La enfermedad de Hunter se transmite ligada al cromosoma X y debido a un acúmulo de heparán sulfato y dermatán sulfato.
- La Xantinuria hereditaria se produce por acumulación de xantina y en menor medida hipoxantina.



REGÍSTRATE

- En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo la reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales.
- La orina con olor a jarabe de arce se produce por alteración en su metabolismo de aminoácidos alifáticos ramificados.

2. Responde si son verdaderos (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones marcando con una cruz correspondiente:

Responde si son verdaderos (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones marcando con una cruz correspondiente:	Verdadero	Falso
La enfermedad de Hunter se transmite ligada al cromosoma sexo	☐	☐
Los intolerantes a isomaltosa/sacarosa se pueden hacer tolerantes a la patata con la edad	☐	☐
Los intolerantes a isomaltosa/sacarosa se pueden hacer tolerantes al almidón con la edad	☐	☐
El mayor número de plaquetas implica un mayor riesgo de sufrir hematomas y sangre en exceso	☐	☐
Para el diagnóstico de la enfermedad de Tauri se utiliza el test de glucagón	☐	☐
Los neutrófilos son leucocitos polimorfonucleares	☐	☐
Alteraciones en la B oxidación cursan con hipoglucemia no cetónica	☐	☐
Elevadas concentraciones de urea en la sangre son indicativas de alteraciones en el ciclo de la urea	☐	☐
El déficit de tiamina impide la síntesis de ácidos grasos	☐	☐
El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos	☐	☐
Alteraciones en la B Oxidación producen hipoglucemia no cetónica	☐	☐

1. Al cromosoma X (hunter)
4. Falso, es la plaquetopenia, menor número de plaquetas
5. Falso, en músculo es el test de isquemia
6. Verdadero

Los xantomas y xantelasmas no son características patognomónicas de las hipertrigliceridemias		X Xantomas: HiperTG+HiperCol Xantelasmas: Hipercol
Las esfingolipidosis son enfermedades lisosomales		
La enfermedad de San Filipo cursa con alteraciones neurológicas por acumulo de dermatan sulfato		
Con valores de amonio plasmático superiores a 40 micromol/l se considera hiperamonemia		
El tiempo de protrombina permite estudiar la hemostasia primaria		
Un hígado cirrótico se señala con una insuficiencia renal crónica		
Todas las glucogénesis cursan con la acumulación de glucógeno		
En todas las glucogénesis se produce un acumulo de glucógeno		
Bajas concentraciones de hemoglobina en la sangre son indicativas de insuficiencia renal crónica		
Bajas concentraciones de Albumina en la sangre son indicativas de insuficiencia hepática crónica		
La ocronosis no es típico de la hornocristinuria		
Los cálculos urinarios de la xantinuria hereditaria son lisos y ovalados con color marrón anaranjado		
El compuesto que tiñe las heces de color azul en la enfermedad de Hartnup es el triptófano		
La osmolalidad del plasma y la orina permiten estudiar la función glomerular renal		
Altas concentraciones de amonio en sangre no son indicativas de alteraciones del ciclo de la urea		
La concentración de homoglobina y de células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario		
La ocronosis es típico de la alcaptonuria		

- 1.Esfingolipidosis verdadera
- 2.San filipo heparan sulfato
- 3.Hiperamonemia >40 verdadera
- 6.Glucogénesis no todas por acumulación, la IX es por déficit
- 9.Ocronosis típico de alcaptonuria
- 10.Xantinuria hereditaria cálculos lisos y ovalados, marrón-naranja, faciles de cortar y apariencia laminada
- 11.Hartnup heces azul indicán
- 12.Altas concentraciones de amonio en sangre si son indicativas de alteraciones ciclo urea (aumento de urea no lo es)
- 13.Concentracion hemoglobina y células sanguíneas siempre en hemograma
- 14.Verdadera

Examen diciembre 2022:

(No es el examen completo, faltan cosas)

Frases elegir:

- La fenilcetonuria es un alteración del TRANSPORTE/METABOLISMO (catabolismo) de la fenilalanina
- Enfermedad NO asociada al cromosoma X es HUNTER/OTRA
- En las intolerancias a los disacáridos se produce un descenso de pH a 5'5 en ORINA/HECES
- La transtiretina o prealbúmina (no recuerdo) es una proteína de fase aguda negativa
- Los monocitos proceden de la línea MIELOIDE/LINFOIDE
- El ?? es para ver las proteínas TOTALES/OTRA
- Para ver la capacidad de síntesis nos fijamos en AMINOTRANSFERASAS/ALBÚMINA
- Enfermedad que no está ligada al sexo HUNTER/HURLER
- Pertenecen a la serie linfocitos LINFOCITOS/OTRO
- La prueba de aclaramiento renal se hace para medir la función GLOMERULAR/TUBULAR
- La TRANSTIRETINA/OTRA es una proteína de fase aguda negativa

Frases V/F y por qué

- La intolerancia al almidón mejora con la edad
- La xanturia hereditaria es una alteración del metabolismo de las purinas → Verdadero
- La mucopolisacaridosis tipo II o de Hunter es debido a una acumulación de queratán sulfato → Falso, heparán y dermatán sulfato
- Las proteínas de fase aguda solo aparecen en la región beta → Falso no aparecen en la región beta
- Los linfocitos son células polimorfonucleares → Falso son mononucleares
- Los constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma son: concentración de albúmina, concentración de las células sanguíneas, índices eritrocitarios y examen morfológico de las células sanguíneas → Falso, concentración de hemoglobina, lo demás si
- Las hipocolesteremias de tipo II, III y IV son hipertriglicéridemias
- El tofo es un tipo de síntoma que aparece en la gota
- Un aumento de creatinina puede indicar problemas de insuficiencia renal
- Todas las proteínas de fase aguda están en la región beta
- La enfermedad de San Filippo es debido a queratán sulfato
- Todas las glucogenosis son debidas a un acúmulo de glucógeno
- (?) enfermedad puede ser debido a un déficit de saposinas
- El envenenamiento, la perfusión y ? son causas de la hepatitis crónica
- Una cirrosis hepática puede ser signo de una insuficiencia renal

Frases completar los huecos:

- El aumento de la región gamma (no recuerdo bien) es _____ (paraproteína)
- Parámetros para ver el estado del hígado (?)
- Para el diagnóstico de las glucogenosis musculares se realiza el test de isquemia
- El valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida en 1 dL de hematíes se llama concentración hemoglobina corpuscular media (CHCM),
- (...) los valores del aclaramiento renal normales están entre x-y ml/min
- Un aumento de plaquetas puede producir trombocitosis (citar enfermedades?)
- La enfermedad de Tauri es tipo IX, muscular



REGÍSTRATE

-Ejercicio de cálculo de aclaramiento renal (una concentración en micromol y la otra en mmol) y decir si puede tener daños y por qué.

-Ejercicio caso clínico de daño en riñón; por qué, en qué factores te basas, con qué factores se confirmaría,

-Ejercicio caso clínico; cuál de los 4 pacientes tiene daño hepático crónico, en qué parámetros te basas, como sabes que es crónico, hay otros parámetros afectados?si es que si indicarlos

-Una banda de paciente sano de QM, VLDL, HDL, LDL y dibujar tu una de paciente con (?) enfermedad tipo I, + marcar en unas casillas que ocurre después de reposo 4C° overnight, que se vería (capa superficial lechosa...)